

TEMA 3.54 • OBSTETRICIA

Psiquiatría Obstétrica

PERFIL EUNACOM 2.01.2.032

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Psiquiatría Obstétrica

Depresión en el Embarazo y Puerperio

Clínica y diagnóstico: Idénticos a la mujer no embarazada. Es frecuente — siempre evaluar el ánimo en controles.

Tratamiento

TABLA 3.54.1: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Leve	Psicoterapia (puede ser suficiente)
Moderada-severa	Psicoterapia + ISRS
ISRS de 1ª línea embarazo	Sertralina (más usada, buena evidencia) o fluoxetina
Depresión psicótica severa refractaria	Terapia electroconvulsiva (TEC) — eficaz y segura en el embarazo

NOTA CLÍNICA

La TEC tiene mala fama injustificada — en depresión severa psicótica embarazada es una excelente opción: eficaz y de acción rápida.

En el Puerperio

TABLA 3.54.2: FÁRMACO VS VENTAJA	
FÁRMACO	VENTAJA
Sertralina	1ª línea — prácticamente no pasa a la leche materna
Brexanolona (EV)	Acción muy rápida (3 días), pero no disponible en Chile; evitar mientras se da lactancia
TEC	Indicada si depresión posparto muy severa

Trastorno Bipolar en el Embarazo

El embarazo puede descompensar el trastorno bipolar — educar a la paciente y red de apoyo para detectar viraje a manía o depresión.

Tratamiento del TB en el embarazo

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Litio y anticonvulsivantes son teratogénicos — especialmente en el 1er trimestre (litio: cardiopatía de Ebstein). Decisión de mantener o suspender se hace **caso a caso** según severidad.
Regla general: Monoterapia en la menor dosis posible.

TABLA 3.54.3: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO PREFERIDO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO PREFERIDO
Manejo de manía aguda en embarazo	Antipsicóticos (quetiapina 1ª línea; risperidona como alternativa) — NO estabilizadores de ánimo de 1ª línea
Mantenimiento 2º–3er trimestre	Litio o risperidona (según guía — litio contraindicado en 1er trimestre)
Manía severa refractaria en embarazo	TEC

NOTA CLÍNICA

Guía nacional (antigua): Litio si 2º o 3er trimestre; contraindicado en 1er trimestre → alternativa: risperidona. En la práctica, se prefiere dejar antipsicótico (risperidona) como primera opción.

Psicosis Puerperal (= Psicosis Posparto)

Causa

- Trastorno bipolar (la gran mayoría de los casos).
- Puede ser el primer episodio de una paciente con TB no diagnosticado previamente
- Muy raro en pacientes sin psicopatología de base (esquizofrenia, etc.)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La psicosis puerperal es una **señal de alarma** para un trastorno bipolar subyacente — requiere seguimiento y diagnóstico psiquiátrico formal.

Clínica

Inicio: Puerperio inmediato (primeras 2 semanas).

Evolución típica:

- Insomnio → ansiedad → labilidad emocional
- Psicosis: alucinaciones, delirios, alteraciones conductuales graves

Diagnóstico: Clínico (no requiere exámenes).

Tratamiento

TABLA 3.54.4: FÁRMACO VS DETALLE	
FÁRMACO	DETALLE
Litio + antipsicótico	1ª línea (ya no hay feto expuesto)
Anticonvulsivante + antipsicótico	Alternativa

NOTA CLÍNICA

El litio está **indicado en el posparto** (no hay riesgo fetal — el bebé ya nació). Manejo igual que una manía del trastorno bipolar. Siempre **buscar y tratar la causa** a largo plazo — el trastorno bipolar requiere seguimiento psiquiátrico crónico.

Resumen Comparativo

TABLA 3.54.5: CUADRO VS MOMENTO			
CUADRO	MOMENTO	FÁRMACO CLAVE	OBSERVACIONES
Depresión embarazo	Cualquier trimestre	Sertralina / fluoxetina	TEC si severa-psicótica
Depresión posparto	Puerperio	Sertralina (no pasa a leche)	Brexanolona si disponible
Manía en embarazo	Cualquier trimestre	Antipsicótico (quetiapina/risperidona)	Evitar litio en 1er trimestre

| Psicosis puerperal | Primeras 2 semanas posparto | Litio + antipsicótico | Causa: TB; buscar diagnóstico |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Psiquiatría Obstétrica: Clínica Inicio: Puerperio inmediato (primeras 2 semanas).... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Psiquiatría Obstétrica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Depresión en el Embarazo y Puerperio
- Tratamiento
- En el Puerperio
- Trastorno Bipolar en el Embarazo
- Tratamiento del TB en el embarazo
- Psicosis Puerperal (= Psicosis Posparto)
- Clínica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PSIQUIATRÍA OBSTÉTRICA)**PREGUNTA 1**

En relación a Psiquiatría Obstétrica: Clínica Inicio: Puerperio inmediato (primeras 2 semanas).... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Psiquiatría Obstétrica se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Psiquiatría Obstétrica debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Psiquiatría Obstétrica requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Psiquiatría Obstétrica es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Psiquiatría Obstétrica no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Psiquiatría Obstétrica?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Psiquiatría Obstétrica. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PSIQUIATRÍA OBSTÉTRICA

Clínica y diagnóstico: Idénticos a la mujer no embarazada. Es frecuente — siempre evaluar el ánimo en controles. :::note La TEC tiene mala fama injustificada — en depresión severa psicótica embarazada es una excelente opción: eficaz y de acción rápida. ::: El embarazo puede descompensar el trastorno bipolar — educar a la paciente y red de apoyo para detectar virage a manía o depresión.